Proces umierania, świadomość i towarzyszenie choremu

Śmierć i umieranie jako różne perspektywy

Umieranie jest procesem zachodzącym w czasie: obejmuje zmiany fizjologiczne, przeżycia chorego i relacje z otoczeniem. **Śmierć** jako kres własnego doświadczenia jest także problemem filozoficznym - sytuacją graniczną, której nie można wcześniej poznać przez osobiste przeżycie. Obserwowanie umierania innej osoby nie daje bezpośredniego dostępu do jej doświadczenia.

Filozoficzne określenie śmierci jako bezpowrotnej utraty świadomości nie jest samodzielnym kryterium medycznym. Brak świadomości może występować u żyjącej osoby. Definicja śmierci i procedura stwierdzenia zgonu wymagają odróżnienia od opisu przeżyć i objawów.

Fizjologiczne wygasanie funkcji życiowych

Agonia to okres narastającej niewydolności podstawowych układów organizmu. W klasycznej terminologii wyróżnia się **vita reducta - życie zredukowane**, z upośledzeniem czynności krążenia, oddychania i ośrodkowego układu nerwowego, oraz **vita minima - życie minimalne**, gdy przejawy tych czynności są bardzo słabe. **Śmierć pozorna - animatio suspensa** oznacza stan stwarzający pozory zgonu mimo zachowanych procesów życiowych.

Śmierć kliniczna jest klasycznym określeniem ustania oddychania i krążenia, które może być odwracalne. **Vita intermedia - życie pośrednie**, czyli okres interletalny, odnosi się do nierównoczesnego obumierania tkanek: część komórek może jeszcze reagować mimo ustania zintegrowanych funkcji organizmu. **Śmierć biologiczna** oznacza nieodwracalne wygasanie funkcji życiowych tkanek i komórek. Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Sądowej, *Wstęp do medycyny sądowej*, konspekt udostępniony w 2025 r..

Proces nie musi u każdej osoby przebiegać według jednego szeregu łatwo rozpoznawalnych etapów. Nagłe zatrzymanie krążenia różni się od długotrwałego umierania w zaawansowanej chorobie.

Objawy i ich znaczenie

Do klasycznych opisów umierania i wczesnych zmian pośmiertnych należą bierne ułożenie ciała, utrata świadomości, brak ruchów oddechowych i tętna, ochładzanie ciała oraz zmiana rysów twarzy określana jako **oblicze Hipokratesa**. Mają różną swoistość i pojawiają się w różnym czasie. Ochłodzenie ciała lub wygląd twarzy nie są równoważne rozpoznaniu zatrzymania krążenia ani śmierci mózgu.

W nagłym zdarzeniu **brak reakcji i brak prawidłowego oddechu** przemawiają za podejrzeniem zatrzymania krążenia. Oddech agonalny nie jest prawidłowym oddychaniem. Źródło: European Resuscitation Council, 2025, *Adult Basic Life Support*, wytyczne. Jest to kryterium rozpoczęcia działań ratunkowych, nie procedura stwierdzania zgonu.

Kryteria śmierci

Ujęcie	Główna idea
Dawne ujęcia somatyczne	Oparcie pewności zgonu na oczywistym, nieodwracalnym zniszczeniu organizmu, np. oddzieleniu głowy od tułowia.
Krążeniowo-oddechowe	Nieodwracalne ustanie funkcji krążenia i oddychania; trzeba odróżnić je od potencjalnie odwracalnego zatrzymania krążenia.
Neurologiczne	Trwałe, nieodwracalne ustanie czynności mózgu, rozpoznane według określonej procedury.

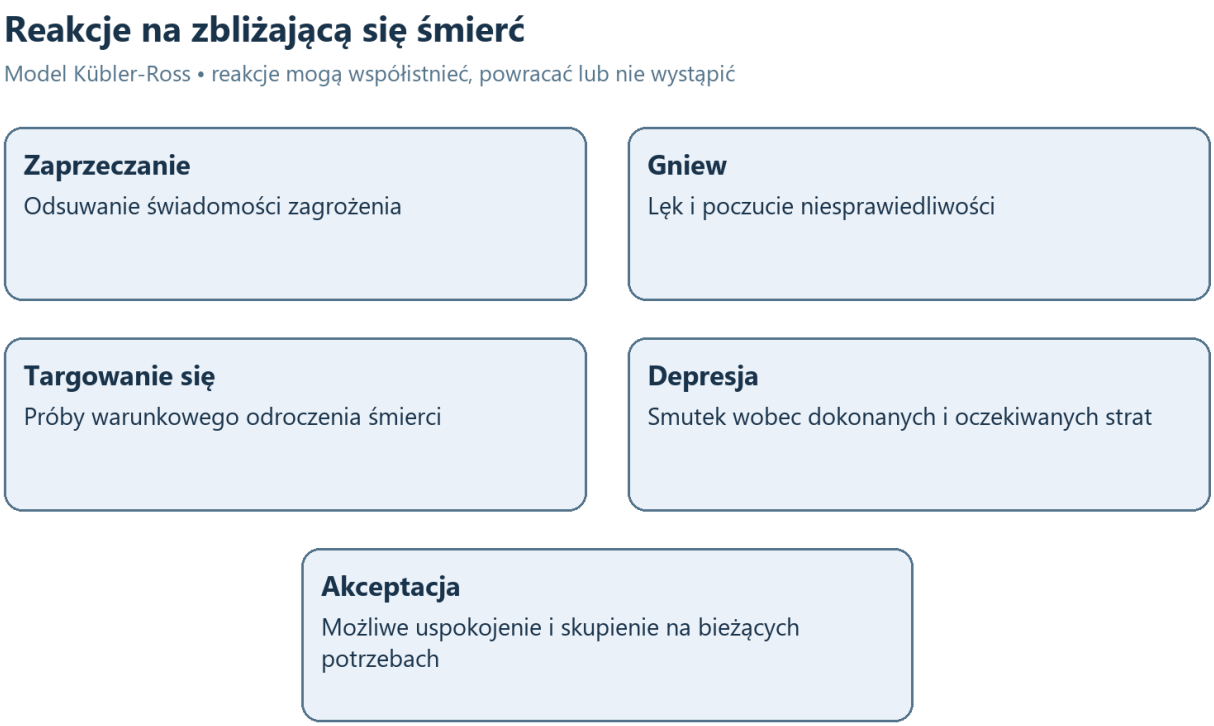
Śmierć mózgu dotyczy nieodwracalnej utraty funkcji mózgu jako całości, a nie samego braku kontaktu z chorym lub samej śpiączki. Stwierdzenie wymaga wykazania określonych warunków i wykluczenia odwracalnych przyczyn zaburzeń. Obowiązująca procedura nie sprowadza się do obserwowania zaniku świadomości. Źródło: Minister Zdrowia, obwieszczenie z 4 grudnia 2019 r., *w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu*, M.P. 2020 poz. 73. Podstawa ustawowa i zrównanie prawidłowego stwierdzenia śmierci mózgu ze stwierdzeniem zgonu: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 43a, tekst jednolity, Dz.U. 2026 poz. 37.

Elisabeth Kübler-Ross - reakcje na zbliżającą się śmierć

Model z *On Death and Dying* (1969) powstał na podstawie rozmów z osobami umierającymi. Obejmuje zaprzeczanie, gniew, targowanie się, depresję i akceptację. Jest **modelem opisowym**, a nie obowiązkowym harmonogramem. Reakcje mogą współistnieć, powracać i nie wystąpić u każdej osoby. Wywiady kliniczne nie pozwalają wyznaczyć uniwersalnego czasu lub kolejności dla całej populacji. Źródło: Elisabeth Kübler-Ross, 1969, omówienie książki i jej ograniczeń przez fundację autorki.

Reakcja	Znaczenie w modelu
Zaprzeczanie i izolacja	Odsuwanie świadomości zbliżającej się śmierci, podtrzymywanie nadziei; możliwe wycofanie lub zachowywanie pozorów zwyczajnego życia.
Gniew	Poczucie niesprawiedliwości, rozdrażnienie, zazdrość wobec życia innych, niechęć lub rozpacz.
Targowanie się	Próby warunkowego odroczenia śmierci, np. przez obietnice lub negocjowanie z Bogiem.
Depresja	Smutek związany ze stratami dokonanymi i oczekiwanymi.
Akceptacja	Możliwe uspokojenie i skupienie na bieżących potrzebach; nie musi oznaczać radości ani aprobaty choroby.

W tym historycznym modelu **depresja reaktywna** odnosi się do poniesionych strat i spraw wymagających uporządkowania, a **przygotowawcza** - do nadchodzącej utraty życia i rozstania z bliskimi. Nazwy te nie zastępują współczesnej diagnozy psychiatrycznej. Smutek lub chwilowa nadzieja nie pozwalają samodzielnie rozpoznać zaburzenia ani określić, jak blisko jest śmierć.



Schemat. Pięć nazw reakcji w modelu Kübler-Ross, bez strzałek porządkujących. Rozmieszczenie nie oznacza etapów obowiązkowych ani ich częstości; źródło: Kübler-Ross (1969) i objaśnienia fundacji autorki wskazane wyżej.

Glaser i Strauss - konteksty świadomości umierania

Trajektoria umierania obejmuje przebieg zmian oraz organizację relacji i opieki. Stan wiedzy pacjenta i otoczenia wpływa na ich wzajemne zachowania. **Kontekst świadomości** opisuje, kto wie o zbliżającej się śmierci i czy można o tym mówić.

Kontekst	Relacja między pacjentem i otoczeniem
Zamknięty	Otoczenie zna rokowanie, a chory nie jest świadomy zbliżającej się śmierci. Poprawę samopoczucia może interpretować jako dowód zdrowienia.
Podejrzewania	Chory dostrzega sygnały i próbuje ustalić, czy umiera; niejasne odpowiedzi mogą podważać zaufanie.
Wzajemnego udawania	Obie strony wiedzą, ale zachowują się tak, jakby nie wiedziały. Może to ograniczać możliwość pożegnania i rozmowy o potrzebach.
Otwarty	Obie strony uznają sytuację i mogą otwarcie się do niej odnosić, także przy podejmowaniu decyzji o opiece.

To typologia interakcji, a nie cztery biologiczne fazy. Jej pierwotnym kontekstem były szpitale i ówczesne praktyki komunikowania rokowania, co ogranicza automatyczne przenoszenie opisów na

wszystkie współczesne środowiska. Źródło: Barney G. Glaser i Anselm L. Strauss, *Awareness of Dying*, 1965, wydawca - zakres i konteksty świadomości.

Konteksty świadomości umierania

Zamknięta świadomość

Otoczenie wie, pacjent nie jest świadomy sytuacji.

Podejrzewanie

Pacjent podejrzewa sytuację i poszukuje informacji.

Wzajemne udawanie

Uczestnicy wiedzą, lecz zachowują się tak, jakby nie wiedzieli.

Otwarta świadomość

Uczestnicy wiedzą i mogą wspólnie rozmawiać o umieraniu.

Układy wiedzy i komunikacji według Glasera i Straussa - nie obowiązkowe etapy.

Schemat. Cztery konteksty świadomości umierania; źródło: Glaser i Strauss, *Awareness of Dying*.

Reakcje bliskich i sposoby towarzyszenia

Bliscy mogą doświadczać lęku, gniewu, smutku i bezradności, a ich sposób reagowania nie musi odpowiadać aktualnej reakcji chorego. **Żałoba antycypacyjna** dotyczy przeżywania oczekiwanej straty jeszcze przed śmiercią. Towarzyszenie nie polega na doprowadzaniu chorego do „właściwego etapu”.

Sytuacja	Pomocna odpowiedź
Chory nie chce rozmawiać o śmierci	Zapytać, ile chce wiedzieć i o czym chce mówić; pozostawić możliwość powrotu do rozmowy.
Gniew lub lęk	Wysłuchać emocji; ustalić, czy dokładają się ból lub inne objawy wymagające pomocy zespołu.
Potrzeba uporządkowania spraw	Pomóc w organizacji kontaktów i decyzji zgodnie z wolą chorego.
Wycofanie i cisza	Towarzyszyć bez przymusu rozmowy; respektować odpoczynek i potrzebę prywatności.
Obciążenie rodziny	Dzielić obowiązki i korzystać ze wsparcia zespołu opieki oraz pomocy psychologicznej.

Warto wcześniej uzgodnić życzenia dotyczące opieki, obecności bliskich i rytuałów. Przekazanie rodzinie informacji o możliwych zmianach w ostatnich dniach może ograniczać dezorientację. Źródło: National Cancer Institute, *Last Days of Life (PDQ®), Patient Version*, materiał o opiece u kresu życia,

dostęp 2026. Opracowanie dotyczy przede wszystkim osób z zaawansowanym nowotworem; nie określa jednego przebiegu dla wszystkich przyczyn umierania.

Powiązania

- Opieka paliatywna - cel opieki obejmuje łagodzenie cierpienia chorego i wspieranie rodziny.
- Trauma i żałoba - odróżnianie spodziewanej straty, żałoby i zaburzeń pourazowych.
- Niejednoznaczna strata - niepewność co do losu osoby zmienia sytuację bliskich.

Źródła internetowe: dostęp 27.10.2026.